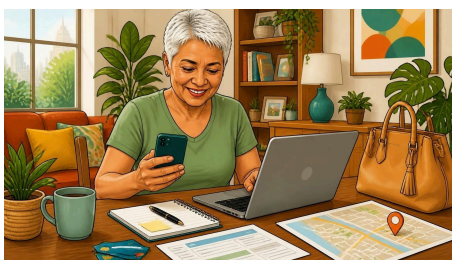


NÍVEL 01 - Adulto normal e sem comprometimento.

Sinais observáveis: Funcionamento cognitivo preservado ou Nenhum déficit objetivo ou subjetivo nas tarefas diárias.

- **Funcionamento Cognitivo Preservado** - Recorda fatos facilmente, narra acontecimentos cotidianos com crítica e coerência, e identifica o nome de objetos inclusive os menos usuais.
- **Autonomia total nas atividades** - Gerência finanças, utiliza dispositivos digitais, aplicativos e se locomove sem qualquer limitação.



- **Ausência de lapso de memória** - Relata ter uma boa memória, sente confiança para assumir novos desafios e percebe que sua idade cronológica não limita seus pensamentos.



Ações do cuidador:

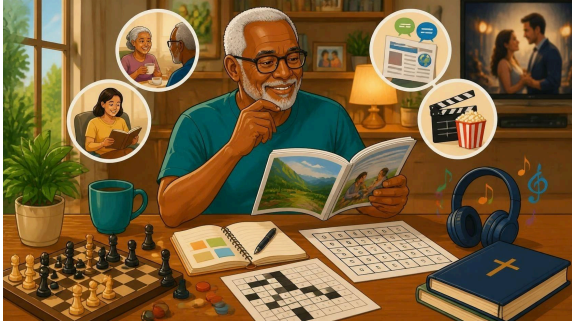
- **Promoção da Vida Física e Social.**

Dica: Incluir a pessoa nas atividades de organização da casa, incentivar a rotina de exercícios corporais e o convívio comunitário como: Ofertar caminhadas no território, acompanhar atividades em centros de vivência.



- **Estímulo à Leitura e Aprendizado.**

Dica: Ofertar jogos que estimulam o raciocínio e a memória executiva como sudoku e paciência, palavras cruzadas e conversação sobre temas de interesse da pessoa idosa.



- **Acompanhamento de rotina**

Dica: Ofertar apoio na organização da rotina, sem interferir na execução, estar atento se atividades que fazia bem, começa ter dificuldade, verificar se a audição está íntegra.

NÍVEL 2 - Esquecimento normal da idade.

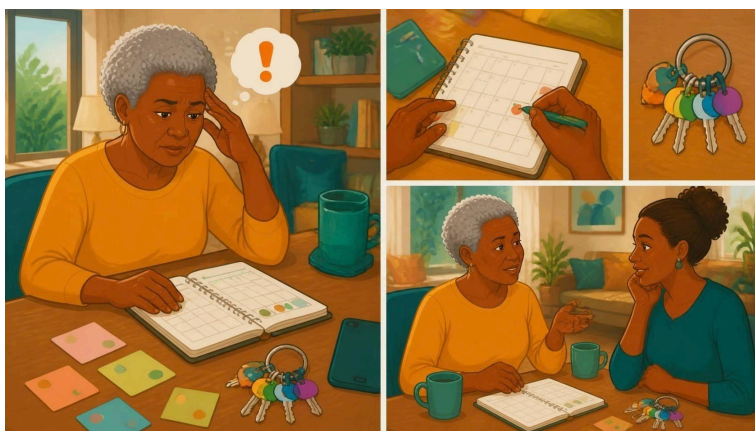
Sinais observáveis:

Queixas leves de esquecimento, compatíveis com o envelhecimento normal. Não interferem na vida funcional.

- **Esquece onde deixou objetos** - coloca objetos habituais em lugares diferentes, acredita que algo está em um lugar diferente do habitual)



- **Dificuldade em lembrar nomes** - esquece o nome das pessoas do dia a dia, esquece de pessoas novas que conheceu recentemente (a trocas de nomes são esperadas, por exemplo, trocar o nome dos netos)
- **Percebe a própria falha** (reconhece que está esquecendo as coisas, começou usar estratégias para sanar as dificuldades por conta própria, pede ajuda, entende que funções do dia a dia estão mas difíceis, tem medos de coisas novas)



Ações do cuidador

- **Usar agendas e lembretes**

Dica: Organizar atividades por período do dia (manhã, tarde, noite); coloque em um papel as atividades da rotina e fora da rotina e fixe na geladeira; incentive que todos os dias tenha o hábito de olhar e programar o dia.

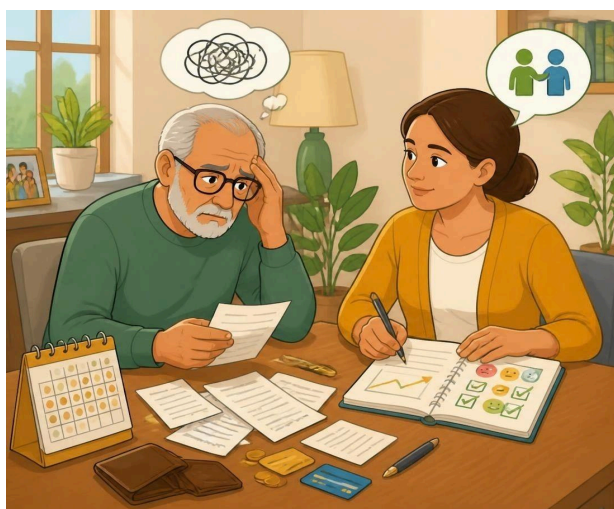


- **Rotina previsível**

Dica: Use quadros com imagens grandes e coloridas mostrando as atividades do dia (acordar, café, higiene, refeições, lazer e dormir) para que o idoso acompanhe visualmente e se sinta orientado. Aponte para as imagens ao explicar o que acontecerá a seguir, comunicando-se com clareza e paciência. *Orientação educativa: procure sempre um profissional de saúde.

- **Observar e registrar mudanças**

Dica: Caso coisas habituais, como por exemplo, pagar contas, fique cada vez mais difícil, é importante entender a dificuldade e fazer roteiros para que continuem sendo feitas.



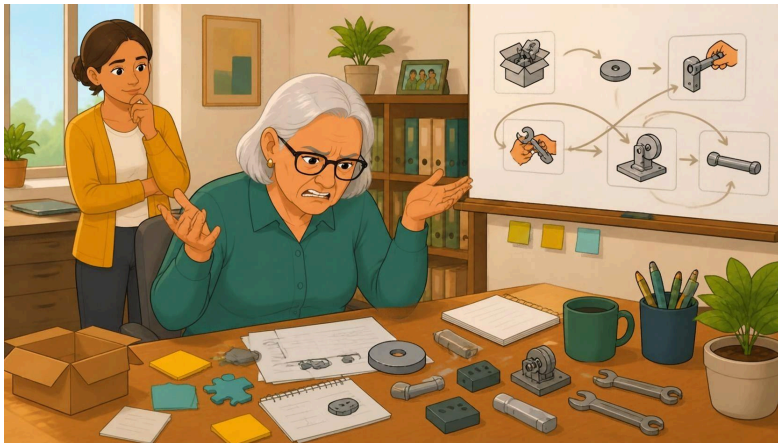
NIVEL 3

Comprometimento em tarefas complexas

Primeiros déficits detectáveis em situações de maior exigência: trabalho, viagens, organização.

Sinais observáveis

- Erra em tarefas complexas no trabalho (quando inicia uma atividade nova, não consegue compreender as etapas e fica irritado)



- Perde-se em locais desconhecidos (em cinemas ou teatros, não consegue ir voltar ao banheiro, ou em lugares abertos, tem dificuldade em se localizar)



- Dificuldade de concentração (perde o foco nos assuntos durante uma conversa, ou comenta algo que não está relacionado ao assunto)

Ações do cuidador

- Reduzir demandas complexas

Dica: Não pedir que realize ações fora da rotina, evitar situações que envolvam conhecimento novos, por exemplo: cozinhar algo que nunca comeu.



- Buscar avaliação cognitiva formal
Dica: Se perceber que coisas que eram feitas sem dificuldade, começaram a ficar difíceis, uma orientação profissional é necessária para descartar o início de alguma doença. Relatar todos os sintomas na consulta é fundamental para que os profissionais envolvidos conheçam todas as habilidades e dificuldades.
- Apoio em finanças e agenda
Dica: Fazer roteiros explicativos do “passo a passo” de cada ação, solicitar que após realizar a tarefa faça uma revisão em outro momento.

Nível 4: Dificuldade em tarefas instrumentais

Falhas claras em atividades instrumentais: lidar com dinheiro, compras, planejar refeições.

Sinais observáveis

- **Dificuldade com finanças e contas** (não consegue fazer contas simples, não identifica o troco correto, erra valores da hora de fazer pagamentos, determina valores muito diferentes da realidade, esqueceu que já pagou uma conta, por exemplo, comprar uma revista por um valor muito alto e achar normal)



- **Erros ao fazer compras:** (faz uma lista de mercado e não compra os itens necessários, compra produtos que não são necessários ou que nunca usou)
- **Esquece eventos recentes:** (participou de jantar com amigos, foi ao cinema, visitou um restaurante novo e não se recorda)
- **Dificuldades motoras:** Perda de equilíbrio, dificuldades de movimentos, dificuldades de se locomover pela casa, esbarra em objetos familiares do ambiente.



Ações do cuidador

- **Supervisionar dinheiro e remédios**

Dica: Fazer uma relação de todos os remédios e modo de uso em ambientes da casa de fácil acesso visual. Usar caixinhas com data e horário para armazenar os remédios; restringir o acesso a aplicativos de banco e limitar a quantidade de dinheiro para acesso. A autonomia deve ser mantida, mas com supervisão, ex.: pode pagar contas, mas limitar a quantidade e fazer checagem.



- **Listas e rotinas simples**

Dica: As tarefas deverão ser descritas de forma simples. Toda vez que incluir uma atividade nova na rotina, deve ser colocada em destaque e lembrada na véspera e no dia, se possível em vários momentos do dia se for necessário. A rotina pode ser feita em cartolina ou lousa, com desenhos e frases curtas e colocada na cozinha e no quarto; Usar o calendário para orientação de tempo e espaço, falando diariamente o dia, mês e ano e tentar associar com notícias que estão ocorrendo no mundo; Fazer também associação de mês e datas com datas comemorativas, por exemplo, dias da mães -> mês de maio, Natal -> em dezembro.



- **Iniciar plano de cuidados**

Dica: Supervisionar saídas, ter marcadores como alarmes para medicação, ou anotar se a quantidade de remédios correta está sendo tomada.

- **Apoio nas dificuldades motoras**

Dica: Verificar se é possível andar em linha reta, colocar uma fita colorida no chão e pedir para caminhar sobre ela, retirar tapetes da casa, colocar barras de apoio em banheiros, afastar móveis muito próximos uns dos outros e aumentar o espaço de passagem.



NIVEL 5: Precisa de ajuda para escolher roupas

Não consegue seleccionar vestuário adequado à ocasião ou ao clima sem orientação.

Sinais observáveis

- Escolhe roupa inadequada ao clima (procura e coloca roupa em locais inadequados ex. geladeira; pega peças quentes em um dia de calor)



- Confusão com datas e lugares (acredita que estamos em outro ano; fala do passado como se fosse atual; se perde no tempo, manhã, tarde e noite; pede para sair em horários inapropriados, ex. de madrugada).
- Precisa de lembretes para se vestir (sai do banho e não quer colocar as roupas; depois de evacuar se recusa a colocar a roupa íntima).

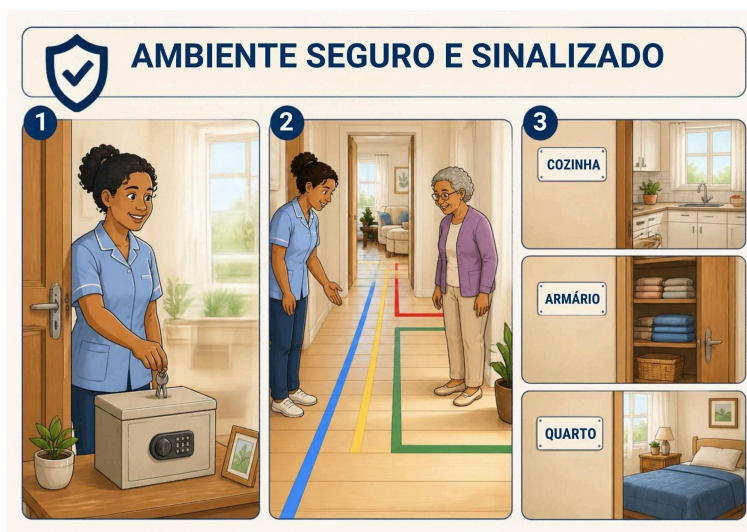


Ações do cuidador

- Separar roupas por dia (não deixe todas as roupas no armário, deixe apenas a roupa que gostaria que a pessoa colocasse; separar por categorias (quente e frio), se não tiver espaço pode colocar em caixas identificadas em um local longe do quarto; já deixe as roupas separadas nas caixas de acordo com as estações do ano).



- Ambiente seguro e sinalizado (tire as chaves das portas e deixe cópias guardadas em um local seguro; coloque fitas coloridas no chão marcando o caminho entre os principais cômodos da casa; coloque etiquetas nomeando cada ambiente e principais objetos, ex: cozinha, armário, quarto, cadeira).



- Apoio domiciliar de cuidador (busque cuidadores ou outros familiares para auxiliar no dia a dia, principalmente no final da tarde em que é possível apresentarem agitação ou agressividade; identifique os cuidadores e pessoas da rotina com fotos e nomes, sendo possível, coloque fotos em que estejam juntos para que seja familiar; crie escalas de rodízio entre os cuidadores para não ter sobrecarga)



NIVEL 6: Ajuda nas atividades básicas

Necessita de auxílio para vestir-se, tomar banho e higiene. Pode surgir incontinência.

Sinais observáveis

- Dificuldade para vestir-se sozinho (coloca as peças de roupas em lugares errados, ex: cueca na cabeça, camisa na perna; não aceita a roupa que foi escolhida).



- Precisa ajuda no banho (o banho pode gerar algumas dificuldades, clique aqui para acessar as orientações mais detalhadas) *LINK QUE LEVA PARA O ITEM DE AUTOCUIDADO E HIGIENE*



- Incontinência urinária e/ou fecal (evacua nas calças; não avisa que quer ir ao banheiro; suja a roupa e não aceita ser limpo)

Ações do cuidador

- Rotina de higiene assistida (ofereça uma peça limpa, familiar e confortável; evite comentários constrangedores sobre aparência ou odor; o uso de fralda pode ser necessário, se houver recusa, explique que é uma calcinha ou cueca diferente e moderna e que ajudará no seu conforto).



- Recusa a troca da fralda (Feche a porta e deixe o ambiente seguro para que ninguém entre, é importante que a pessoa não fique envergonhada ou constrangido; ninguém se troca na frente de outras pessoas, por isso, explique cada passo e exponha apenas a região que precisa ser higienizada, preservando a intimidade; nunca faça a troca à força; usar uma boneca como exemplo pode ajudar).
- Prevenir quedas e lesões de pele (se estiver acamado é fundamental que mude de posição a cada 4 horas, a fim de evitar feridas na pele (aqui colocar uma imagem das posições possíveis); use hidratantes no corpo diariamente, a pele

pode ficar muito ressecada; tire todos os tapetes e obstáculos da casa; mantenha corredores acessíveis e livres; barras de proteção são fundamentais em vários ambientes; verifique com profissional a necessidade de uso de bengala, cadeira de rodas e outros dispositivos).

- Apoio emocional ao cuidador (nesse momento a sobrecarga da pessoa que cuida aumenta de forma significativa, é fundamental pedir ajuda para os cuidadores, ter momentos de lazer, criar rotina de cuidado e rodízio entre os cuidadores, mas se a ansiedade e tristeza forem frequentes procure ajuda médica)

FIGURAS??

6a · *vestir* - (não utilizar roupas e peças com botões e zíper, podem machucar ou abrir com facilidade; escolha roupas mais largas e confortáveis; faça em você primeiro para dar o modelo)

6b · *banho* - *acessar item específico*

6c · *higiene*

6d · *incont. urinária*

6e · *incont. fecal*

NÍVEL 7: Perda da fala e da mobilidade

Estágio mais avançado: redução progressiva da fala, da marcha e do controle motor.

Sinais observáveis

- Vocabulário muito limitado ou ausente (não consegue se comunicar nem com frases simples; perda de compreensão em geral; deixa de conhecer as pessoas a sua volta; não inicia ou mantém diálogo).
- Perda da capacidade de andar e sentar (não mantém apoio ao sentar-se, dificuldade para andar e ficar em pé mesmo que por pouco tempo, rigidez em pernas e braços).
- Perda do sorriso e do controle da cabeça (mantém sempre a cabeça para baixo; não mantém contato de olho; fica com a mesma expressão a maior parte do tempo).

Ações do cuidador

Cuidados paliativos e conforto (Utilizar tom de voz suave, toque afetivo e chamados pelo nome antes de qualquer manejo físico; criar um ambiente calmo, com iluminação natural adequada, controle de barulhos e temperatura agradável quando possível; incorporar elementos significativos da história de vida, como músicas calmas do interesse do paciente e aromas familiares; realizar movimentações delicadas nas articulações no momento do banho ou troca de roupas; oferecer escuta ativa e validação emocional ao cuidador e à família nesta fase.

Prevenir úlceras e aspiração (Implementar rotina de mudança de posição a cada 2 horas na cama e a cada 30–60 minutos na poltrona/sofá; utilizar almofadas pneumáticas, coxins de espuma e rolos posicionadores para aliviar a pressão; realizar as refeições e oferta de líquidos sempre em posição sentada ou com a cabeça elevada; realizar higiene da boca de forma frequente).

Nutrição e hidratação assistidas (adequar a consistência dos alimentos, ex: pastosos, e de líquidos, ex: espesso, reduzindo o risco de engasgos; oferecer alimentos com contraste visual e em pratos coloridos que se destacam do alimento; não apressar as refeições; respeitar as pausas e identificar sinais de recusa, ex: fechar a boca, virar o rosto, evitando a oferta forçada.

***REVISADO ATÉ AQUI*.**

7a · ~6 palavras7b · 1 palavra7c · não anda7d · não senta7e · não sorri7f · sem controle cefálico

FALAR DE CAA

Cuidados especiais no dia a dia

Pequenas adaptações podem tornar a rotina mais segura, respeitosa e previsível para todos.

COISAS QUE PODEM ACONTECER

“Você pegou meu dinheiro.” Acolha a preocupação e proponha procurar junto com a pessoa, com calma. Evite discutir se ela esqueceu onde guardou.

“Você roubou minha joia.” Reconheça o valor afetivo do objeto, peça que ela o descreva e ajude na busca. Depois, combinem um lugar habitual para guardá-lo.

Esconde objetos e depois acusa alguém. Procure primeiro nos locais onde costuma guardar coisas e observe se há esconderijos recorrentes. Evite ridicularizar ou mexer em seus pertences às escondidas.

“Tem alguém entrando em casa.” Fique por perto, verifique o ambiente com ela e reduza sombras ou ruídos que possam causar medo. Não trate a sensação de perigo como invenção.

Acusa o companheiro de infidelidade. Responda com tranquilidade e ofereça companhia. Discussões para “provar” o contrário tendem a aumentar a tensão.

Diz à família que está sendo maltratada. Ouça a queixa com seriedade, observe o que pode ter causado desconforto e converse com a família sobre o ocorrido. **Toda alegação de maus-tratos precisa ser examinada**, mesmo quando a pessoa tem demência.

Tem medo de ser mandada para uma instituição. Explique o que acontecerá naquele momento e mantenha uma rotina previsível. Evite ameaças ou promessas sobre decisões que ainda não foram tomadas.

Não reconhece a filha ou outro familiar. Aproxime-se devagar, apresente-se pelo nome e mantenha um tom afetuoso. Não exija que ela se lembre de quem você é.

Comunicação e contato

- **Não responde ou fala apenas palavras soltas:** converse de frente, use frases curtas e dê tempo para a resposta. Observe também o olhar, os gestos e a expressão.
- **Repete sons ou parece não reagir:** verifique possíveis desconfortos, como dor, frio ou necessidade de higiene. Continue oferecendo companhia, mesmo sem resposta evidente.
- **Não chama familiares pelo nome:** apresente-se com naturalidade, sem testar sua memória. A voz familiar, a presença e a rotina ainda podem trazer segurança.
- **Evita o olhar ou se assusta com a aproximação:** chegue devagar, pela frente, diga quem você é e avise antes de tocar.
- **Responde melhor ao toque ou à música:** use essas formas de contato se forem bem recebidas, com volume baixo e sem excesso de estímulos. Verifique também possíveis dificuldades auditivas
- **Fale de modo simples, calmo e respeitoso.** Diga uma coisa de cada vez, espere a pessoa reagir e acompanhe as palavras com presença e gestos. Acolha o sentimento sem confirmar algo que você não sabe se aconteceu, sem discutir para provar que ela está errada e sem fazer promessas que não pode cumprir.

FRASES QUE DEVEM SER GUARDADAS

Situação

Exemplo de fala

Acusa alguém de pegar um objeto	“Vejo que isso está preocupando você. Posso ajudar a procurar.”
Não reconhece um familiar	“Meu nome é Ana. Vou ficar aqui um pouco com você.”
Está com medo	“Estou perto de você. Vamos olhar o que está acontecendo?”
Resiste ao banho ou à troca	“Vou explicar o que farei e manter você coberto. Podemos começar devagar?”
Quer sair de casa	“Parece importante ir a esse lugar. Conte-me mais.”
Acorda durante a noite	“Ainda é noite. Estou aqui para ajudar você a se acomodar.”
Já não consegue falar	“Vou conversar com você e observar como está se sentindo. Não precisa responder.”
Fica aflita durante o cuidado	“Vou parar agora. Podemos tentar de outro jeito depois.”

Alimentação

- **Mantém o alimento na boca ou demora a engolir:** ofereça a refeição com a pessoa sentada e espere a boca esvaziar antes de apresentar outra porção. Se isso se repetir, solicite avaliação fonoaudiológica.
- **Não abre a boca para comer:** considere cansaço, dor ou desconforto na boca. Faça uma pausa e tente novamente mais tarde, sem forçar.
- **Tosse ao beber água:** interrompa a oferta naquele momento e procure avaliação de deglutição. Não mude a consistência dos líquidos por conta própria, se a tosse ocorrer com frequência interrompe a oferta e procure o médico.
- **Não consegue usar o talher:** adapte o prato e os utensílios e permita que participe da refeição tanto quanto conseguir. A escolha de alimentos para comer com as mãos deve considerar a segurança da deglutição.

Conforto corporal e higiene

- **Passa muito tempo na cama ou na poltrona:** ajude a mudar de posição conforme suas necessidades e as orientações da equipe de saúde.

- **Apresenta vermelhidão nos pontos de apoio:** alivie a pressão sobre o local e procure orientação da enfermagem. Não massageie a área avermelhada.
- **Não consegue dizer onde dói:** observe caretas, choro, agitação ou resistência ao movimento e relate essas mudanças à equipe de saúde.
- **Mantém o corpo rígido ou as mãos fechadas:** movimente apenas com orientação profissional, sem forçar. Observe se há feridas ou dificuldade para higienizar as mãos.
- **Fica agitado durante o cuidado íntimo:** explique cada etapa, preserve sua privacidade e mantenha cobertas as partes do corpo que não estão sendo cuidadas.

Sinal de alerta: uma piora que surge de repente não deve ser atribuída automaticamente à evolução da demência, ou seja, aquela situação pode ter piorado por uma situação clínica e não pela avanço da demência, por exemplo, ficar rebaixado, por uma infecção urinária.

Saiba Mais autocuidado e higiene

ORIENTAÇÕES PARA O BANHO

Recusa o banho. Verifique se o banheiro está confortável, preserve a privacidade e convide a pessoa a participar do que conseguir fazer sozinha. Deixe a temperatura como habitual.

Afirma que já tomou banho. Evite confrontar sua lembrança. Apresente uma etapa simples, como trocar a roupa ou se refrescar, e conduza a atividade sem pressa.

Fica irritada ao tirar a roupa. Avise antes de tocar ou remover cada peça, mantenha o corpo coberto e respeite o que ela consegue fazer por conta própria.

Grita ou tenta bater durante o banho. Interrompa o banho, afaste-se o suficiente para manter todos em segurança e ofereça uma toalha. Retome a higiene em outro momento, sem usar força.

Tem medo da água na cabeça. Avise antes de molhar, ofereça um apoio firme e tente lavar o cabelo separadamente, com pouca água e no ritmo da pessoa, use uma caneca ou um recipiente pequeno, evite colocar embaixo do chuveiro.